



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 32 — Cefaleia na Emergência: red flags (SNOOP10), cefaleias primárias (migrânea, tensional, em salvas) e secundárias graves (HSA, meningite, HIC, arterite temporal, trombose venosa, HII)

Triagem por red flags, regra de Ottawa para HSA, tratamento da crise migranosa sem opioide, punção lombar, quando transferir para TC — cenário: PS sem TC; TC/neurologia na referência

Código	PS-ND-32	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Cefaleia é 2–4% dos atendimentos do PS; 90% são primárias (migrânea, tensional, em salvas) e vão para casa; 1–3% são secundárias com risco de vida (HSA, meningite, hemorragia, trombose venosa, dissecação, arterite, hipertensão intracraniana). Sem TC no PS, o instrumento é a **anamnese dirigida por red flags** — quem tem uma transfere; quem não tem trata a crise e recebe alta com plano. O segundo objetivo é tratar bem a migrânea: **sem opioide**, com antiemético dopaminérgico + AINE/dipirona ± triptano, e sem perpetuar a cefaleia por uso excessivo de analgésico.

Fontes de ancoragem: Do TP, et al. **Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNOOP10 list.** Neurology 2019;92:134 [SNOOP10]; Perry JJ, et al. **Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache (Ottawa SAH Rule).** JAMA 2013;310:1248; validação CMAJ 2017;189:E1379 [OTTAWA]; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the ED with acute headache. Ann Emerg Med 2019;74:e41 [ACEP 2019]; Orr SL, et al. **Management of adults with acute migraine in the emergency department: the American Headache Society evidence assessment.** Headache 2016;56:911 [AHS 2016]; **Sociedade Brasileira de Cefaleia.**

Recomendações para o tratamento da crise migranosa (edição vigente 2023/2024) [SBCE — VERIFICAR]; International Classification of Headache Disorders, 3rd ed. (ICHD-3), Cephalalgia 2018; van de Beek D, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect 2016;22:S37 [ESCMID 2016]; Protocolos 03 (HSA/AVC), 15 (HAS), 05 (seps) desta série.

Convenção de confiança: critérios e doses conforme SNOOP10/Ottawa/AHS 2016/SBCE; **[VERIFICAR]:** metoclopramida/clorpromazina/dipirona/cetorolaco/sumatriptano injetável em estoque, material de punção lombar e transporte de líquido, tempo até TC na referência, oftalmoscópio.

1. Queixa — a anamnese que decide tudo (5 perguntas + red flags)

Pergunta	O que discrimina
1. Como começou? (instalação)	Súbita, máxima em <1 min ("thunderclap", "a pior da vida", "explosão") = HSA até prova em contrário; gradual em horas = migrânea/tensional; progressiva em dias-semanas = massa/HIC/HII
2. É a primeira vez ou é igual às de sempre?	Padrão conhecido e idêntico (migrânea com aura habitual) tranquiliza; primeira cefaleia intensa, ou diferente das habituais = red flag; mudança de padrão em cefaleia crônica
3. O que acompanha?	Febre/rigidez de nuca/rash (meningite), déficit focal/convulsão/confusão (lesão estrutural), vômitos em jato/piora ao deitar/à noite (HIC), perda visual transitória/zumbido pulsátil (HII), claudicação mandibular/dor no couro cabeludo (arterite), náusea/fotofobia/fonofobia (migrânea), lacrimejamento/ptose unilateral em crises curtas (salvas)
4. Contexto	Idade >50 (nova), gestação/puerpério (pré-eclâmpsia, TVC, apoplexia), câncer, HIV/imunossupressão, anticoagulante, trauma recente, esforço/sexo/Valsalva (HSA, dissecção), ortostática (hipotensão liquórica), uso de analgésicos >10-15 dias/mês (cefaleia por uso excessivo), CO (vários em casa com cefaleia)
5. O que já fez e o que funciona	Resposta a triptano/AINE não exclui secundária; opioides prévios; migrânea conhecida com plano

2. Clínica — red flags, regras de decisão e diagnósticos

2.1 Red flags — SNOOP10 (qualquer um → investigar/transferir para TC ± PL)

Letra	Red flag	Suspeita
S	Sistêmicos: febre, rigidez de nuca, rash, perda de peso, mialgia; câncer/HIV/imunossupressão	Meningite/encefalite, abscesso, metástase, arterite
N	Neoplasia conhecida	Metástase
N	Neurológico: déficit focal, confusão, convulsão, papiledema, rebaixamento	Lesão estrutural, HIC, encefalite
O	Onset súbito (thunderclap, máxima em ≤1 min)	HSA, dissecção, TVC, SVCR, apoplexia hipofisária
O	Older: início após 50 anos	Arterite temporal, massa, HSA
P	Padrão novo ou mudança do padrão habitual (frequência, intensidade, características)	Secundária
P	Posicional: piora ao levantar (hipotensão liquórica) ou ao deitar/Valsalva/tosse (HIC)	Fístula liquórica, massa, Chiari, HII
P	Precipitada por esforço, tosse, sexo, Valsalva	HSA, dissecção, massa de fossa posterior
P	Papiledema / perda visual transitória / zumbido pulsátil	HII, massa, TVC, hipertensão maligna
P	Progressiva (dias-semanas) ou atípica; refratária ao tratamento habitual	Massa, hematoma subdural, TVC
P	Puerpério / gestação	Pré-eclâmpsia/eclâmpsia, TVC, SVCR, apoplexia, AVC
P	Painful eye / sintomas autonômicos atípicos	Glaucoma agudo, Tolosa-Hunt, salvas (se típico, primária)
P	Pós-trauma	Hematoma epi/subdural (Protocolo 29)
P	Patologia imune (HIV, imunossupressão)	Infecção oportunista, linfoma
P	Painkiller overuse (>10-15 dias/mês) ou droga nova	Cefaleia por uso excessivo; SVCR (simpaticomiméticos, triptanos, ISRS)

2.2 Regra de Ottawa para HSA [Perry 2013/2017] — aplicar em cefaleia súbita que atinge o máximo em ≤ 1 h, sem trauma, alerta, sem déficit, ≥ 15 anos

Investigar HSA (TC ≤ 6 h e/ou PL) se **qualquer um: idade ≥ 40 anos • dor ou rigidez de nuca • perda de consciência testemunhada • início durante esforço • cefaleia thunderclap** (pico instantâneo) • **limitação da flexão cervical ao exame**. Sensibilidade 100% para HSA; nenhum critério = HSA muito improvável. **TC de crânio sem contraste em ≤ 6 h do início, em aparelho moderno e laudada por radiologista, tem sensibilidade $\sim 100\%$ e dispensa PL; após 6 h, TC negativa exige punção lombar** (xantocromia/eritrócitos que não clareiam) ou angio-TC.

2.3 Cefaleias secundárias graves — reconhecer

Condição	Pistas	Conduta no PS
Hemorragia subaracnóidea	Thunderclap, vômitos, rigidez de nuca, síncope, PA alta, déficit; "cefaleia sentinela" dias antes	PA < 160 , analgesia (sem AINE/AAS), antiemético, cabeceira 30°, nimodipina 60 mg VO 4/4 h após confirmação → TC + neurocirurgia (Protocolo 03)
Meningite bacteriana / encefalite	Febre + cefaleia + rigidez de nuca/Kernig/Brudzinski (só 2 de 4 da tétrade em 95%: febre, rigidez, confusão, cefaleia), petéquias/púrpura (meningococo), convulsão, confusão (encefalite herpética: alteração de comportamento, afasia)	Hemoculturas + ceftriaxona 2 g IV 12/12 h em ≤ 1 h (+ ampicilina 2 g 4/4 h se > 50 anos/imunossuprimido; + aciclovir 10 mg/kg 8/8 h se encefalite) + dexametasona 10 mg IV 6/6 h antes/junto da 1ª dose; PL no PS se sem contraindicação (7.4) — não atrasar o antibiótico pela PL/TC ; isolamento respiratório 24 h; notificação imediata; quimioprofilaxia de contatos (meningococo)
Hipertensão intracraniana (massa, hematoma, hidrocefalia)	Progressiva, pior ao deitar/de manhã, vômitos, papiledema, déficit, paralisia de VI par, alteração de consciência	Cabeceira 30°, evitar hipotensão/hipóxia, manitol/NaCl 3% se herniação (Protocolo 29) → TC
Trombose venosa cerebral	Mulher jovem, ACO/gestação/puerpério, trombofilia, desidratação; cefaleia progressiva ou súbita, papiledema, convulsão, déficit bilateral/flutuante	Anticoagulação (HBPM) após imagem (angio-TC/RM venosa) — transferir
Arterite de células gigantes	> 50 anos, cefaleia temporal nova, claudicação mandibular, dor no couro cabeludo, artéria temporal espessada/sem pulso, perda visual, polimialgia; VHS > 50 /PCR alta	Prednisona 40-60 mg/dia imediatamente (1 g IV metilprednisolona se perda visual); VHS/PCR; biópsia em ≤ 2 semanas (não atrasar o corticoide) — referência
Glaucoma agudo de ângulo fechado	Dor ocular/periorbitária intensa, olho vermelho, pupila média fixa, córnea opaca, halos, náusea; idoso, no escuro	Acetazolamida 500 mg VO/IV, timolol/pilocarpina colírio, analgesia → oftalmologia urgente
Hipertensão intracraniana idiopática	Mulher jovem obesa, cefaleia diária, zumbido pulsátil, obscurecimentos visuais, papiledema, VI par; TC normal	PL diagnóstica/terapêutica (pressão de abertura > 25 cmH ₂ O) após imagem; acetazolamida; neurologia/oftalmo
Pré-eclâmpsia / eclâmpsia	Gestante > 20 sem ou puerpéra, PA $\geq 140/90$, cefaleia, escotomas, epigastralgia	MgSO ₄ , anti-hipertensivo (Protocolos 14/15) → obstetrícia (Santa Casa)
Emergência hipertensiva / encefalopatia / SVCR	PA muito alta + cefaleia + confusão/convulsão; thunderclap recorrente com vasoconstritores	Protocolo 15; SVCR: suspender simpaticomiméticos/triptano, nimodipina — referência
Dissecção cervical	Cefaleia/cervicalgia unilateral + Horner/AIT após manipulação/trauma/esforço	Angio-TC — Protocolo 03
Intoxicação por CO	Vários moradores com cefaleia, náusea, tontura; aquecedor/carvão em ambiente fechado	O ₂ 100%, COHb (Protocolo 23)
Hipotensão líquórica (pós-PL, espontânea)	Ortostática (melhora deitado), após punção	Repouso, hidratação, cafeína; blood patch se persistir (referência)

2.4 Cefaleias primárias — critérios ICHD-3 (resumo)

Tipo	Crítérios	Armadilha
Migrânea	≥5 crises de 4-72 h; ≥2 de: unilateral, pulsátil, moderada/forte, piora com atividade; + ≥1 de: náusea/vômito, foto e fonofobia; aura (visual/sensitiva/afásica, 5-60 min, reversível) em 1/3	Migrânea com aura atípica (motora, prolongada, súbita) = investigar; primeira crise em >50 anos = red flag; "migrânea" que muda = secundária até prova
Tensional	Bilateral, em pressão/aperto, leve/moderada, não piora com atividade, sem náusea, ≤1 de foto/fonofobia; 30 min-7 dias	Diagnóstico de exclusão se intensa; uso excessivo de analgésico
Em salvas (trigêmino-autonômica)	Unilateral orbitária/temporal, muito intensa , 15-180 min, 1-8x/dia, em "salvas" de semanas; lacrimejamento, congestão nasal, ptose/miose, sudorese ipsilaterais; inquietação	Homem 20-40 a; primeira salva → imagem (secundária em 5%); O ₂ 100% 12-15 L/min por 15-20 min e sumatriptano SC são os tratamentos
Cefaleia por uso excessivo de medicamento	≥15 dias/mês de cefaleia com uso de analgésico ≥10-15 dias/mês por >3 meses	Não resolve com mais analgésico; suspender/reduzir + profilaxia (ambulatorial)

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais, temperatura	Febre (meningite, arterite), PA muito alta (encefalopatia, HSA, pré-eclâmpsia), bradicardia + HAS (Cushing)
Sensório, orientação, linguagem	Confusão/afasia = secundária (encefalite, HSA, massa)
Rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski; flexão cervical ativa	Meningite/HSA (Ottawa: limitação da flexão)
Fundo de olho (oftalmoscópio ou POCUS de nervo óptico >5 mm)	Papiledema = HIC/HII/TVC; hemorragias sub-hialoides (HSA)
Pupilas, motricidade ocular, campos visuais, VI par	Anisocoria (herniação, aneurisma de comunicante posterior), paralisia de VI (HIC), hemianopsia
Déficit focal (força, sensibilidade, reflexos, marcha, coordenação, fala)	Lesão estrutural; ataxia (fossa posterior)
Artérias temporais (pulso, espessamento, dor), couro cabeludo	Arterite; sinais de trauma
Olho (hiperemia, pupila média fixa, córnea, pressão digital)	Glaucoma agudo
Seios da face, ouvidos, dentes, ATM, cervical	Sinusite (raramente causa cefaleia isolada), otite, dor referida
Pele	Petéquias/púrpura (meningococcemia — emergência), zóster oftálmico
Sinais autonômicos unilaterais (lacrimejamento, ptose, congestão)	Salvas/trigêmino-autonômica
Gestante: PA, reflexos, edema	Pré-eclâmpsia

4. Propedêutica armada

Cefaleia primária típica sem red flags não precisa de exames. Exames entram com red flags — e a maioria implica transferência para TC.

Exame	Para que serve	Quando
TC de crânio sem contraste	HSA (≤6 h: ~100%; depois cai), hemorragia, massa, hidrocefalia, edema	Qualquer red flag; Ottawa positivo — referência (transferir)

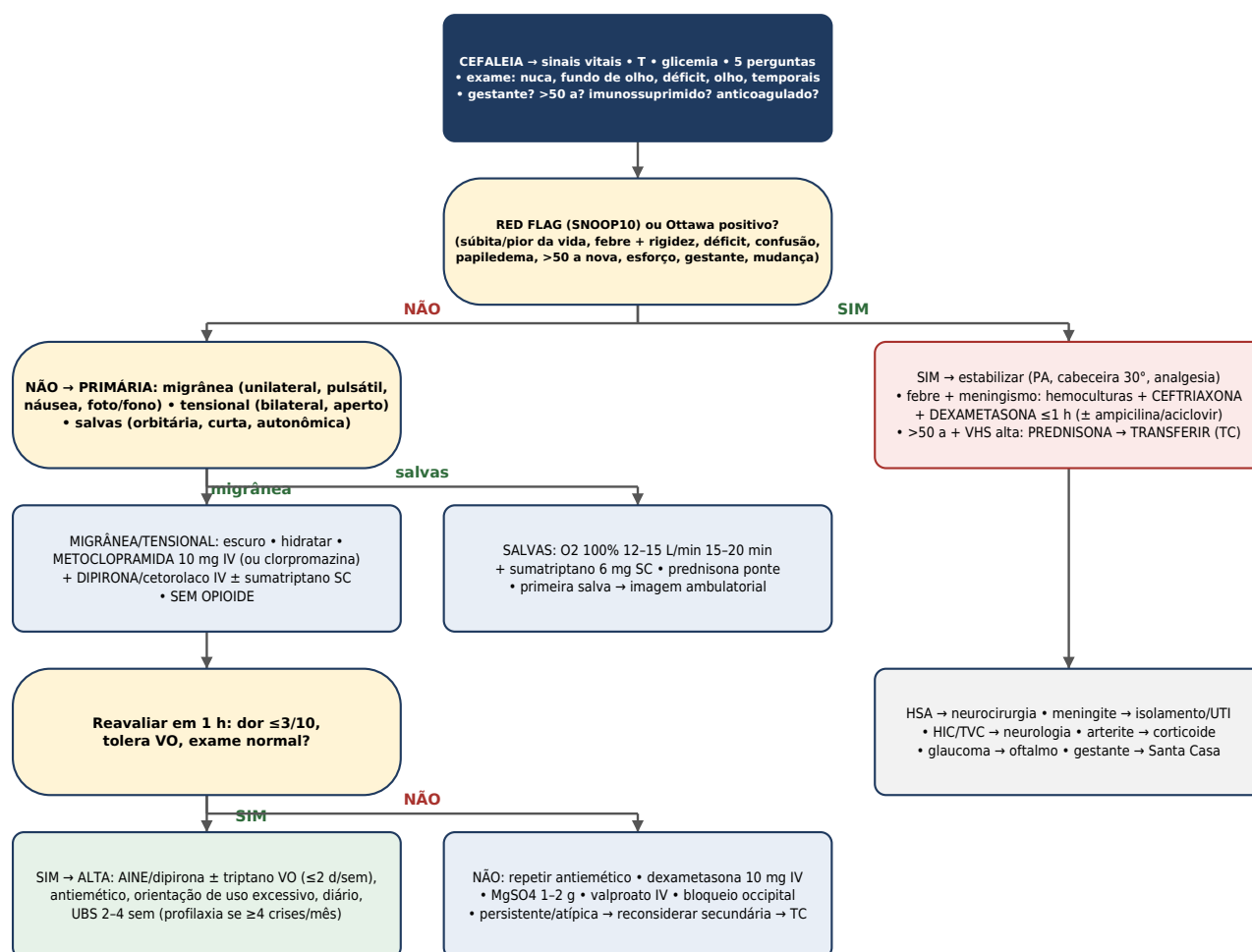
Exame	Para que serve	Quando
Punção lombar	Meningite (celularidade, proteína, glicose, Gram, cultura, látex/PCR); HSA com TC negativa >6 h (xantocromia, eritrócitos constantes nos 4 tubos); HII (pressão de abertura)	Febre + cefaleia + sinais meníngeos (no PS, se sem contraindicação — 7.4); HSA suspeita com TC negativa — na referência
Angio-TC / angio-RM / RM com venografia	Aneurisma, dissecação, TVC, SVCR, massa, Chiari, hipotensão liquórica	Referência
Hemograma, PCR, VHS , glicemia, eletrólitos, creatinina, coagulograma, hemoculturas, β -hCG	Infecção, arterite (VHS >50), pré-eclâmpsia, coagulopatia antes de PL, gestação	Red flags; >50 anos com cefaleia nova (VHS/PCR); febre
Glicemia capilar, SpO_2 , COHb	Hipoglicemia, hipóxia, CO	Confusão; exposição
Pressão intraocular (tonômetro/estimativa)	Glaucoma agudo	Olho vermelho doloroso
ECG	Isquemia (cefaleia como equivalente anginoso é raro), QT antes de antieméticos	Idoso, cardiopata, antes de clorpromazina/ondansetron a em risco

5. Fisiopatologia

O parênquima cerebral não dói; doem as meninges, os vasos (artérias intra e extracranianas, seios venosos), os nervos cranianos e as estruturas extracranianas. Na **migrânea**, uma onda de depressão cortical alastrante (aura) e a ativação do sistema trigeminovascular liberam CGRP e outros neuropeptídeos, com vasodilatação dural, inflamação neurogênica e sensibilização central (alodinia, fotofobia, náusea por ativação do tronco) — daí a eficácia de antieméticos dopaminérgicos (metoclopramida/clorpromazina agem no tronco e na dor), AINEs e triptanos (agonistas 5-HT_{1B/1D} que fecham a vasodilatação e inibem o CGRP), e a ineficácia/dano dos opioides (não atuam no mecanismo, aumentam recorrência, sensibilização e uso excessivo). Na **cefaleia em salvas**, a ativação hipotalâmica com descarga parassimpática explica a periodicidade, os sinais autonômicos e a resposta ao O_2 a 100%. Nas **secundárias**, o mecanismo é mecânico ou inflamatório: o sangue subaracnóideo irrita as meninges instantaneamente (thunderclap); a infecção meníngea gera dor, rigidez e edema; o aumento da pressão intracraniana distende dura e vasos (pior deitado, à noite, com Valsalva) e comprime o VI par e o nervo óptico (papiledema); a arterite inflama a artéria temporal e ameaça a oftálmica (cegueira em horas); a trombose venosa eleva a pressão venosa e causa infartos hemorrágicos. A **cefaleia por uso excessivo** é uma sensibilização iatrogênica: cada analgésico reduz o limiar da próxima crise — a única saída é retirar.

6. Fluxo de atendimento [SNOOP10; Ottawa; AHS 2016; SBCe, adaptado ao PS sem TC]

Red flag → transfere; sem red flag → trata a crise sem opioide e reavalia em 1 h. Meningite suspeita recebe antibiótico antes de qualquer exame.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → triagem por red flags documentada (5 perguntas + exame)	≤30 min
Suspeita de meningite → hemoculturas + ceftriaxona + dexametasona	≤1 h (antes de PL/TC/transferência)
Thunderclap / Ottawa positivo → saída para TC	≤1 h (TC em ≤6 h do início é decisiva)
Arterite suspeita → prednisona	Imediata (antes da biópsia)
Migrânea → 1ª medicação	≤30 min; reavaliação em 1 h; decisão de alta em ≤4 h
Salvas → O ₂ 100%	≤10 min

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Crise migranosa no PS [AHS 2016; SBCe; ACEP 2019] — combinar antiemético dopaminérgico + analgésico; sem opioide

Fármaco	Dose	Evidência / observações
Metoclopramida	10 mg IV (em 15 min, diluída — menos acatisia), repetir 1× em 30-60 min; criança 0,1-0,2 mg/kg	AHS: nível B (deve ser oferecida); trata dor e náusea; acatisia (difenidramina 25 mg IV previne/trata)
Clorpromazina	12,5-25 mg IV lenta (ou IM) com SF 500 mL antes (hipotensão)	Muito eficaz; hipotensão ortostática, sedação, QT
Haloperidol / proclorperazina	Haloperidol 2,5-5 mg IV; proclorperazina 10 mg IV (se disponível)	Alternativas dopaminérgicas
Dipirona	1-2 g IV (criança 15 mg/kg)	Eficaz em migrânea (evidência brasileira); segura
Cetorolaco	30 mg IV/IM (15 mg >65 anos); ou diclofenaco 75 mg IM; ibuprofeno 400-600 mg VO	AHS: nível B; contraindicado em DRC, úlcera, gestante 3º trimestre, HSA suspeita
Sumatriptano	6 mg SC (início 10-15 min; repetir 1× após 1 h, máx. 12 mg/dia); VO 50-100 mg; nasal 20 mg	AHS: nível B; contraindicado em DAC/AVC/HAS não controlada/gestação/vasoespasma/ergot ou triptano nas últimas 24 h/hemiplégica; não em cefaleia atípica antes de excluir secundária [VERIFICAR estoque]
Dexametasona	10 mg IV (ou 4-8 mg) dose única após analgesia	Reduz recorrência em 24-72 h (NNT ~9); não trata a dor aguda; evitar repetição frequente
Sulfato de magnésio	1-2 g IV em 15 min	Migrânea com aura, gestante, refratária (evidência moderada)
Valproato de sódio IV	500-1.000 mg IV em 30 min (se disponível)	Refratária; sem gestante
Difenidramina	25-50 mg IV/IM	Só para prevenir/tratar acatisia — não é analgésico
Bloqueio de nervo occipital	Lidocaína 1-2% 1-2 mL (± bupivacaína) bilateral	Refratária, gestante; treinamento
Hidratação	SF 0,9% 500-1.000 mL se desidratado/vômitos	Rotina não altera dor; útil antes de clorpromazina
Opioides (morfina, tramadol, codeína)	Evitar (AHS/ACEP: não recomendados como 1ª linha)	Menos eficazes, mais recorrência, retorno ao PS, sensibilização, uso excessivo; só resgate excepcional documentado
Ergotamina/cafeína	Evitar no PS	Interações, vasoconstrição, uso excessivo

7.2 Cefaleia em salvas e outras primárias

Condição	Tratamento
Salvas — crise	O₂ 100% 12-15 L/min em máscara não reinalante por 15-20 min sentado (70-80% respondem) + sumatriptano 6 mg SC (ou nasal 20 mg); lidocaína 4% intranasal ipsilateral como adjuvante; evitar opioide/AINE (pouco eficazes)
Salvas — ponte/prevenção	Prednisona 60 mg/dia 5 dias com desmame em 2 semanas ou bloqueio occipital; verapamil 240-480 mg/dia (com ECG) — neurologia
Tensional	Dipirona/paracetamol/AINE VO; relaxamento; sem opioide/benzodiazepínico; se ≥15 dias/mês → profilaxia (amitriptilina) na APS
Cefaleia por uso excessivo	Explicar; suspender o analgésico excessivo (abrupto para simples/triptano; gradual para opioide/BZD); ponte com naproxeno 500 mg 12/12 h ou prednisona curta; profilaxia (topiramato/amitriptilina/propranolol) — UBS/neurologia
Cefaleia pós-PL	Repouso, hidratação, cafeína 300-500 mg VO/IV, analgesia; blood patch se >72 h/grave (anestesia — referência)

7.3 Secundárias — condutas específicas no PS (resumo; ver protocolos referidos)

Condição	Conduta
Meningite bacteriana [ESCMID 2016]	Hemoculturas (2) → ceftriaxona 2 g IV 12/12 h (criança 100 mg/kg/dia) + dexametasona 0,15 mg/kg (10 mg) IV 6/6 h por 4 dias , 1ª dose antes/junto do ATB; + ampicilina 2 g 4/4 h (>50 a, gestante, imunossuprimido, etilista — Listeria); + vancomicina se pneumococo resistente suspeito; + aciclovir 10 mg/kg 8/8 h se encefalite (confusão, afasia, convulsão, RM temporal); isolamento respiratório 24 h; notificação imediata; profilaxia de contatos íntimos (rifampicina 600 mg 12/12 h 2 dias ou ciprofloxacino 500 mg dose única) se meningococo/Hib; transferir (UTI se rebaixamento/choque/púrpura)
HSA	Protocolo 03: PAS <160, analgesia (dipirona/opioide — sem AINE), antiemético, nimodipina após confirmação, sem antitrombótico, neurocirurgia
Arterite de células gigantes	Prednisona 40–60 mg/dia (1 mg/kg) imediatamente; perda visual/amaurose: metilprednisolona 1 g IV/dia 3 dias; AAS 100 mg; VHS/PCR; biópsia de temporal em ≤14 dias; reumatologia/ofthalmologia
Glaucoma agudo	Acetazolamida 500 mg VO/IV, timolol 0,5% + pilocarpina 2% colírios, manitol 1 g/kg se refratário, analgesia/antiemético, decúbito dorsal → oftalmologia em horas (iridotomia)
HII	Após TC/RM normal: PL com manometria (terapêutica), acetazolamida 250–500 mg 12/12 h → 1–4 g/dia, perda de peso; oftalmologia (campo visual) — risco de cegueira
TVC	HBPM 1 mg/kg 12/12 h após confirmação (mesmo com componente hemorrágico); anticonvulsivante se crise; transferir
Hipertensão intracraniana / massa	Protocolo 29 (cabeceira, osmótico se herniação, dexametasona 10 mg IV se edema vasogênico tumoral) → neurocirurgia
Pré-eclâmpsia	Protocolos 14/15 → Santa Casa

7.4 Punção lombar no PS — indicações, contraindicações e técnica

Item	Conduta
Indicação no PS	Suspeita de meningite/encefalite (após hemoculturas e sem atrasar o antibiótico); HSA com TC negativa >6 h (na referência); HII (após imagem)
TC antes da PL quando	Déficit focal, papiledema, rebaixamento/Glasgow <12, convulsão recente, imunossupressão/HIV, história de lesão do SNC, >60 anos (ESCMID) — se qualquer um: ATB + dexametasona e transferir para TC (PL depois)
Contraindicações	Coagulopatia (INR >1,5, plaquetas <50.000, anticoagulante), infecção no local, instabilidade, sinais de herniação
Técnica	Decúbito lateral ou sentado, L3–L4/L4–L5, antisepsia, anestesia local, agulha 22–25G (atraumática reduz cefaleia pós-PL), medir pressão de abertura (decúbito; normal 6–20 cmH ₂ O), coletar 4 tubos (citologia, bioquímica, Gram/cultura/látex/PCR, reserva), 1–2 mL cada; transporte imediato ao laboratório (líquor não refrigera para cultura) [VERIFICAR fluxo laboratorial]
Interpretação	Bacteriana: turvo, células >500–1.000 (PMN), proteína >100, glicose <40 (<40% da glicemia), Gram +; viral: linfócitos, glicose normal; HSA: eritrócitos que não clareiam do 1º ao 4º tubo, xantocromia (>12 h); TB/fúngica: linfócitos, glicose baixa, proteína alta

7.5 Alta — pacote

- Diagnóstico presumido escrito (tipo de cefaleia primária); confirmação de que red flags foram checados e ausentes.
- Receita de crise: AINE/dipirona/paracetamol ± triptano VO (sumatriptano 50–100 mg, naratriptano 2,5 mg) + antiemético (metoclopramida/domperidona) — **usar em ≤2 dias/semana**; sem opioide/ergotamina/BZD.
- Orientação escrita: sinais de alarme para retorno (cefaleia súbita/pior da vida, febre + rigidez, confusão, fraqueza, visão dupla, convulsão, piora progressiva), evitar uso excessivo (>10 dias/mês), diário de cefaleia, gatilhos (sono, jejum, caféina, álcool, estresse), hidratação.
- Retorno na UBS em 2–4 semanas; profilaxia se ≥4 crises/mês ou incapacitantes (propranolol, amitriptilina, topiramato, flunarizina — APS/neurologia); primeira salva, aura atípica, >50 anos, refratária → neurologia/imagem ambulatorial.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Thunderclap/Ottawa positivo (HSA), déficit focal, rebaixamento, convulsão, papiledema, sinais de herniação, TCE com critério	Imediata (≤ 1 h)	TC + neurologia/neurocirurgia — referência [VERIFICAR: Tabajara Ramos × Santa Casa × terciária]
Meningite/encefalite suspeita (ATB e dexametasona já dados)	Imediata; isolamento	Enfermaria/UTI com infectologia — Tabajara Ramos
Arterite com perda visual; glaucoma agudo; TVC; HII com perda visual	Imediata / mesmo dia	Oftalmologia / neurologia — referência
Gestante/puérpera com cefaleia + PA $\geq 140/90$ ou red flag	Imediata	Obstetrícia — Santa Casa
Migrânea refratária após 2ª linha (4–6 h), vômitos incoercíveis/desidratação, estado migranoso (> 72 h)	Mesmo dia	Observação/neurologia — Tabajara Ramos
Primária tratada, sem red flags	Alta com plano	UBS (2–4 semanas)

8.2 Transporte e documentação

- HSA/HIC: cabeceira 30°, PA controlada, antiemético, monitor, via aérea se Glasgow ≤ 8 ; meningite: máscara cirúrgica no paciente/N95 na equipe; gestante: DLE.
- Relatório: características da cefaleia (início, tempo até o pico, intensidade, localização, acompanhantes), red flags presentes, exame neurológico e fundo de olho, PA, temperatura, exames (VHS/PCR, hemoculturas, líquido — se colhido, resultados e tubos enviados), **antibiótico/dexametasona/corticoide (dose/hora)**, analgesia dada e resposta, medicações de uso (anticoagulante, ACO), gestação.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192; notificação imediata de meningite suspeita (vigilância).

8.3 O que o PS precisa ter

- Oftalmoscópio (ou POCUS de nervo óptico); material de PL com agulha atraumática, manômetro, tubos e fluxo de líquido; hemocultura; VHS/PCR em ≤ 2 h.
- Estoque: metoclopramida, clorpromazina, dipirona IV, cetorolaco, sumatriptano SC/VO, dexametasona, MgSO_4 , difenidramina, ceftriaxona, ampicilina, aciclovir, prednisona, acetazolamida, timolol/pilocarpina colírio, máscara não reinalante e O_2 de alto fluxo (salvas).
- Cartaz SNOOP10/Ottawa na sala de triagem; folheto de alta (sinais de alarme, uso excessivo, diário).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com red flags (SNOOP10) e exame neurológico (incl. nuca e fundo de olho) documentados	$\geq 95\%$
% de thunderclap/Ottawa positivo com saída para TC em ≤ 1 h	$\geq 90\%$
% de meningite suspeita com hemocultura + ceftriaxona + dexametasona em ≤ 1 h	100%
% de migrânea tratada com antiemético dopaminérgico + AINE/dipirona (protocolo) e sem opioide	$\geq 90\%$
Opioide em migrânea sem justificativa documentada (evento sentinela)	0
% de altas com orientação escrita (alarme, uso excessivo) e retorno na UBS	$\geq 90\%$
Retorno em 72 h com diagnóstico secundário grave após alta por "cefaleia primária" (revisão de caso)	Registrar
Retorno em 7 dias por migrânea (recorrência) — meta de dexametasona/plano	Registrar; reduzir

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
TC ≤6 h dispensa PL na HSA	ACEP 2019 (nível B) e Ottawa: sim, em TC moderna com radiologista; alguns serviços mantêm PL. Adotado: dispensa se ≤6 h e laudo especializado; PL/angio-TC após 6 h
Regra de Ottawa	Sensibilidade 100%, especificidade baixa (~15%) — aumenta TC; adotada como triagem de segurança
Clorpromazina x metoclopramida	Ambas nível B (AHS); clorpromazina mais hipotensão. Adotadas ambas; metoclopramida primeiro por segurança
Dexametasona na migrânea	AHS: oferecer para prevenir recorrência (nível B); dose 4-10 mg. Adotado 10 mg dose única
Dipirona	Não consta na AHS (indisponível nos EUA); SBCe/evidência brasileira: eficaz. Adotada
Opioides	AHS/ACEP: não recomendar; SBCe: evitar. Adotado como evento sentinela
Dexametasona na meningite	ESCMID/IDSA: antes/junto do ATB em suspeita de pneumococo/Hib; benefício em países de baixa renda questionado. Adotada
TC antes da PL	ESCMID: critérios listados; IDSA semelhante; sem TC local, os critérios definem transferência antes da PL. Adotado
Sumatriptano SC, clorpromazina, ceterolaco, agulha atraumática, oftalmoscópio	Disponibilidade [VERIFICAR]
Recomendações SBCe	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]

10. Referências

- Do TP, Remmers A, Schytz HW, et al. Red and orange flags for secondary headaches in clinical practice: SNNOOP10 list. *Neurology* 2019;92(3):134-144.
- Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti ML, et al. Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. *JAMA* 2013;310(12):1248-1255. Perry JJ, Sivilotti MLA, Sutherland J, et al. Validation of the Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule in patients with acute headache. *CMAJ* 2017;189(45):E1379-E1385. Perry JJ, et al. Sensitivity of computed tomography performed within six hours of onset of headache for diagnosis of subarachnoid haemorrhage. *BMJ* 2011;343:d4277.
- American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with acute headache. *Ann Emerg Med* 2019;74(4):e41-e74.
- Orr SL, Friedman BW, Christie S, et al. Management of adults with acute migraine in the emergency department: the American Headache Society evidence assessment of parenteral pharmacotherapies. *Headache* 2016;56(6):911-940. Friedman BW, et al. Randomized trial of IV dexamethasone to prevent relapse in acute migraine. *Neurology* 2007;69:2038-2044.
- Sociedade Brasileira de Cefaleia. Recomendações para o tratamento da crise migranosa / Diretrizes brasileiras (edição vigente) [VERIFICAR]. Headache Classification Committee of the IHS. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). *Cephalalgia* 2018;38(1):1-211.
- van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. *Clin Microbiol Infect* 2016;22(Suppl 3):S37-S62. Tunkel AR, et al. IDSA practice guidelines for the management of bacterial meningitis. *Clin Infect Dis* 2004;39:1267-1284. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde — meningites.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de cefaleia (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração